الحماية في الحوادث المختلفة

الحماية في حوادث الصعق الكهربائي:

يقطع المسعف التيار الكهربائي أو يطلب من أحد الأشخاص قطع التيار، لا يجوز للمسعف أن يقترب من المصاب وهو حافي القدمين أو يديه مبللتين، ثم يمسك بخشبة طويلة ويحاول إبعاد .المصاب عن مصدر الكهرباء

الحماية في حوادث الحرائق:

إبلاغ الجهات المختصة (الدفاع المدني–الإطفاء) وفي حال ضرورة التدخل لإخراج المصاب يبلل المسعف جسمه بالماء أو يلف جسمه ببطانية مبللة بالماء ثم يدخل إلى مكان الحريق زحفاً .أو بشكل القرفصاء لأن الأكسجين أثقل من بقية الغازات ويقوم بسحب المصاب

الحماية في حوادث الغرق:

الإبلاغ وطلب النجدة وعلى المسعف ألا يعرض حياته للخطر بالقفز خلف الغريق لأن إخراج الغريق يتطلب خبرة ولا يتدخل المسعف إلا إذا كان الغريق في مكان قليل العمق أو يكون قريباً منه بحيث يلقي إليه بعضاً أو حبل... (طريقة إسعاف الغريق في بحث اصابات الجهاز .التنفسي)

في حالات تسرب الغازات:

يمتنع المسعف عن الدخول لمكان التسرب الغازي إلا إذا كان محصوراً في غرفة فهنا عليه ألا يضغط على أي زر كهربائي أو استعمال الهاتف أو استعمال شمعة أو قداحة. يدخل المسعف إلى الغرفة وهو حابس تنفسه حيث يفتح النوافذ بسرعة ويخرج من الغرفة ليتنفس من جديد ثم .يدخل ثانية لسحب المصاب إلى الخارج بسرعة

حماية ممتلكات المصاب:

يجب الحفاظ على ممتلكات المصاب (محفظته- ساعته- حقيبته) وتسليمها لذويه أو للجهات المختصة (الشرطة مثلاً) أو للمشفى ويأخذ وصل استلام بذلك

فحص المصاب:

يقوم المسعف بإجراء فحص أولي للمصاب لمعرفة طبيعة الإصابة وذلك حسب التسلسل التالي:

فحص الوعي

عندما نصل إلى المصاب نتأكد فوراً من وعيه ومدى استجابته لردات الفعل (الصوت-الألم). إذا نستخدم في فحص الوعي: التنبيه الألمي + التنبيه اللفظي. على الشكل التالي:

نقوم بقرص الودابين مع استخدام التنبيه اللفظي حيث يصرخ المسعف باسم المصاب إذا كان يعرفه أو بسؤاله عن حاله وعما أصابه

وذلك أربع مرات

قرص الودابين (٤ مرات). .... فيك شي(٤ مرات)

إذا لم يستجب يكون عندها في حالة غيبوبة وفي حال استجابته نقوم باستجوابه وسؤاله عن ملابسات وظروف الحادث الذي تعرض له. أما عند الرضيع فيفحص الوعي بقرص حلمة الثدي أو كعب القدم ٤ مرات.

فحص التنفس:

إن فحص التنفس ضروري لدى المصاب بالغيبوبة وذلك لأنه عند حصول الغيبوبة يفقد الجهاز العصبي سيطرته الكاملة على كافة الأجهزة والأعضاء ومنها الجهاز العضلي فيحدث ارتخاء عضلي وما يهمنا هنا هو ارتداد قاعدة اللسان وإغلاقها للمجرى التنفسي لذا وجب فحص الوظيفة التنفسية وتفقده. **الطريقة**: يعمل المسعف على تحرير المسالك التنفسية بإمالة الرأس إلى الوراء وذلك بأن يضع إحدى يديه على جبين المصاب ويستخدم إصبعين من اليد الأخرى يوضعان على عظم الذقن(السبابة والوسطى)، كما يفك زر القميص وكذلك ربطة العنق والحزام.

لفحص الوظيفة التنفسية وذلك بأن (Check – Listen – feel) (C.L.F) يطبق المسعف تقنية C.L.F:

يضع أذنه فوق فم وأنف المصاب وهو ينظر إلى حركة الصدر والبطن.

يرى: يلاحظ المسعف حركة الجزء الأعلى من البطن وحركة الصدر.

يسمع: يسمع إذا كان الهواء يدخل ويخرج مع كل حركة تنفسية.

يشعر: يشعر بسخونة هواء الزفير الخارج من المريض واصطدامه بوجه المسعف.

تفحص الوظيفة التنفسية ما بين ٥–١٠ ثواني. وفي حال كان المكان الموجود فيه المصاب مظلماً يضع المسعف يده على صدر المصاب عند تطبيق C.L.F.

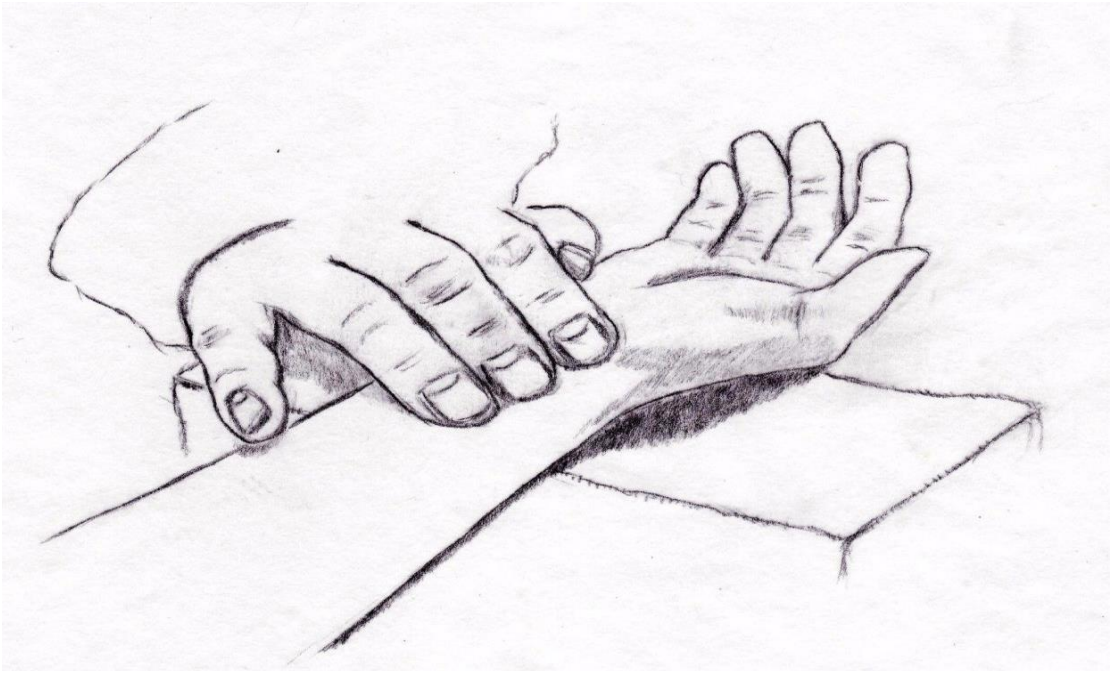
أما عند الرضيع: يتم أولاً تحرير المسالك التنفسية وذلك بوضع منشفة أو ضمادات بين كتفي الرضيع، وذلك لأن كتلة الرأس عند الرضيع كبيرة فلا يمكن إمالته للخلف وتركه حيث يعود مباشرة إلى وضعه الأولي، ثم تطبق تقنية C.L.F.

فحص النبض.

إن النبض الشرياني هو انعكاس لعمل القلب، فالقلب ينقبض وينبسط (يخفق) عدة مرات وهذه الخفقات تختلف حسب العمر وحسب الجنس وتخضع للعوامل الخارجية (رياضة-تعب) والداخلية (المرض) وكل خفقة تنتقل إلى الشرايين الرئيسية التي نستخدمها لقياس النبض . يجب عند قياس النبض أن ننتبه إلى عدة أمور :الانتظام – السرعة – التواتر .

يفحص النبض عند البالغ من الشريان السباتي في العنق بوضع السبابة والوسطى فقط دون الإبهام على مسار الشريان لمدة ٥ ثواني إذا لم نجد النبض نقيسه من الجهة الأخرى لمدة ٥ ثواني أيضاً.

يمكن قياس النبض من الشريان الكعبري في المعصم إلا أن السباتي أفضل. وعند الرضيع يقاس النبض بنفس طريقة السابقة ولكن من بين حلمتي الثدي



فحص الجهاز الدوراني.

لملاحظة وجود نزيف عند المصاب، قد يكون النزف ظاهر وقد يكون باطن أي لم يظهر فوق .ثياب المصاب، كما يتم فحص أسفل المصاب فقد يكون النزف غير ظاهر للعيان

فحص الجهاز المحرك

يتم فحص وجود كسور أو خنوع عند المصاب وذلك بجس العظام بواسطة أصابع المسعف .وذلك بهدوء ولطف حتى لا نؤلم المصاب

بعد أن يتم فحص المصاب بالتسلسل السابق يتم أيضاً تحديد عدد الإصابات ونوعية الإصابة وأماكن وجود الإصابات

نقل المصاب إلى المشفى مع مراقبة الوظائف الحيوية

ينقل المصاب إلى المشفى حسب أولوية النقل في حال تعدد الإصابات، فقد لا تكون سيارات الإسعاف كافية لنقل المصابين جميعهم دفعة واحدة والأطباء هم يقررون أولوية النقل، مع العلم .أن أولوية النقل تختلف حسب الحالة

أثناء نقل المصاب إلى المشفى يلتزم المسعف بمراقبة الوظائف الحيوية لدى المصاب من أجل .التدخل السريع في حال حدوث أي خلل في أحدها

مراقبة الوعي

.قرص الودابين عند الكبار أو حلمة الثدي عند الصغار مع التنبيه اللفظي

.الاستجابة للألم. ردات فعل الجسم

فحص التنفس

.يراقب انتظام عملية التهوية وتواترها .C.L.F تتم بتحرير المسالك التنفسية مع طريقة

فحص النبض

يفحص النبض من خلال الطريقة المشروحة سابقاً (يفحص وجود النبض) كما يراقب مواصفات النبض هل هو بطيء أو سريع، سطحي أو عميق

فحص العين
يراقب البؤبؤين لأن اتساعهما يدل على عدم وصول الأكسجين إلى الدماغ كما يراقب حركة الترميش – لون صلبة العين.
العين السوداء هي نتيجة حدوث نزيف تحت الجلد المحيط بالعين قد يكون مصاباً بكسر في الجمجمة لو كنت تشعر بالرؤية المزدوجة.
فحص الجلد
يراقب لون الجلد (الازرقاق يدل على الاختناق).
الجفاف أو التعرق (التعرق البارد دليل وجود الصدمة حرارة الجسم
فحص الأذن
يراقب خروج سائل زهري (دليل نزيف داخلي في الرأس)، أو خروج دم (دليل وجود جرح خارجي في الأذن)
فحص الأنف
يراقب خروج دم أو سائل مخاطي .تراقب عملية التهوية من خلال الأنف.
فحص الفم: تراقب عملية التهوية - يراقب خروج دم أو إقياء أو لعاب.
يراقب خروج أصوات (الغرغرة) - يراقب لون الشفتين.
بعد أن يقوم المسعف بالخطوات السابقة ويسلم المصاب إلى الطبيب الأخصائي ويشرح له حالة المصاب والإسعافات التي قدمها له فهنا تنتهي مهمة المسعف.
فحص الوجه
ينظر المسعف إلى لون وجه المصاب، فقد يكون مصفراً أو شديد الاحمرار وربما كان مائلاً إلى الزرقة إذا كان التنفس متأثراً بالإصابة. وفي الوقت نفسه يتحسس المسعف حرارة وجه المصاب هل هو ساخن أو بارد مع ملاحظة حالة الجلد هل هو جاف أو ندي أو يعرق بغزارة.
فحص الجمجمة:
يمرر المسعف يده بلطف فوق فروة رأس النصاب بحثا عن أي نزف أو تورم أو أي أثر يدل عللى وجود كسر
فحص الصدر:
يفحص المسعف أضلاع الصدر للتأكد من استواء وضع حركة الأضلاع في أثناء التنفس ويلاحظ عدم وجود أي جرح يمتص الهواء، ثم يفتش في الأضلاع عن أي بروز أو انخفاض يمكن أن يدل على وجود كسر كما يتحسس عظم القص أيضاً.
فحص الترقوة:
يفحص المسعف الترقوتين ويفتش عن عدم الانتظام فيهما ويُفحص الكتفين للبحث عن علامات تشوه فيهما.
ويتحسس الحوض من الجانبين بعناية ويبحث عن عدم وجود كسر كما يلاحظ أية علامة تدل على سلس في البول أو البراز

فحص الطرفين العلويين

يفحص المسعف عظام العضدين، ثم عظام الساعدين والرسغين واليدين والأصابع ويفتش بعناية عن وجود أي تشوه في الشكل أو تورم يدل على كسور. ويفتش في الساعدين عما إذا كان المصاب يلبس سواراً طبيّاً تحذيرياً لإصابته بداء السكري أو يحمل علامات حقن قد تدل على إدمان على المخدرات.

فحص الطرفين السفليين

يفحص المسعف الوركين والفخذين والرضفتين وعظم الركبتين وعظمتي كل ساق والكاحلين والقدمين وأصابعهما بطريقة فحص الذراعين نفسها



.

كيفية إجراء الفحص

يجب إجراء فحص عام للمصاب، وذلك لاكتشاف أي تهديد محتمل الحدوث لحياته سواء كان المصاب واعياً أم فاقداً للوعي. فعندما يقوم المسعف بفحص المصاب **يجب إتباع ما يلي:**

عدم تحريك المصاب كثيراً تحاشياً لتفاقم الإصابة

الفحص بدءاً من الرأس وانتهاءً بالقدمين

استعمال كل الحواس: النظر، والسمع، و اللمس، والشم

المقارنة دائماً بين جانبي جسم المصاب، لأن ذلك يسهل البحث عن أي تورم أو تشوه يحتاج إلى إسعاف اولي.

العوامل المساعدة على التشخيص.

وقائع الحادث :يعتمد التشخيص على معلومات تؤخذ من الظروف المحيطة ومن المصاب نفسه، ومن المارة: فتسجيل وقائع الحادث. يؤدي سؤال المصاب عن الأعراض وفحصه للبحث عن العلامات إلى التشخيص الدقيق. والجدول الآتي يبين عناصر التشخيص

الأعراض التي يشعر بها المصاب عند سؤاله

الألم -فقدان الحركات الطبيعية - فقدان الإحساس - البرودة - الحرارة - العطش الغثيان- الضعف-فقدان الذاكرة -الإغماء -الدوار -فقدان الوعي المؤقت -الإحساس بكسر العظم

الملاحظة بالنظر

التنفس - نوع وكمية النزف - الجروح - الأجسام الغريبة - لون الوجه -التورم -تشوه الشكل الكدمات -السلس -الأفعال اللإرادية -الاستجابة للمس -القيء -آثار الإبر

الملاحظة باللمس

:الرطوبة -الحرارة -النبض -التورم -الانتفاخ -تشوه الشكل -عدم الانتظام- التألم باللمس.

الملاحظة بالشم.

الغاز الكحول .الاحتراق .النفس .

الملاحظة بالسمع

القرقة العظمية- الأنين- .النفس .

العلامات الخارجية

إذا كان المصاب فاقداً وعيه يفتش المسعف جيوبه وحقيبة يده أو محفظة أوراقه للبحث عن أي شيء يساعد على فهم وضعه الصحي. فبطاقات مواعيد المستشفى أو العيادات أو بطاقات المعلومات قد تكشف أنه مصاب بالسكري أو أي مرض آخر، أو أنه يتعرض لنوبات صرعية. .كما أن العثور على قطع السكر أو الجلوكوز يدل على أنه يعاني من داء السكري

ثمة العديد من وسائل التحذيرات الطبية يحملها الأشخاص الذين لديهم مشكلة طبية، وتكون بشكل ميدالية أو سوار توضع في الرسغ أو حول العنق أو في سلسلة المفاتيح وتحتوي على قصاصة ورق تصف حالة المريض.

لهذا يجري البحث عنها وتحميلها إلى الشرطة أو رجال الإسعاف لأنها تفيد في التعرف على حالة المصاب الصحية وتسرع في علاجه

